

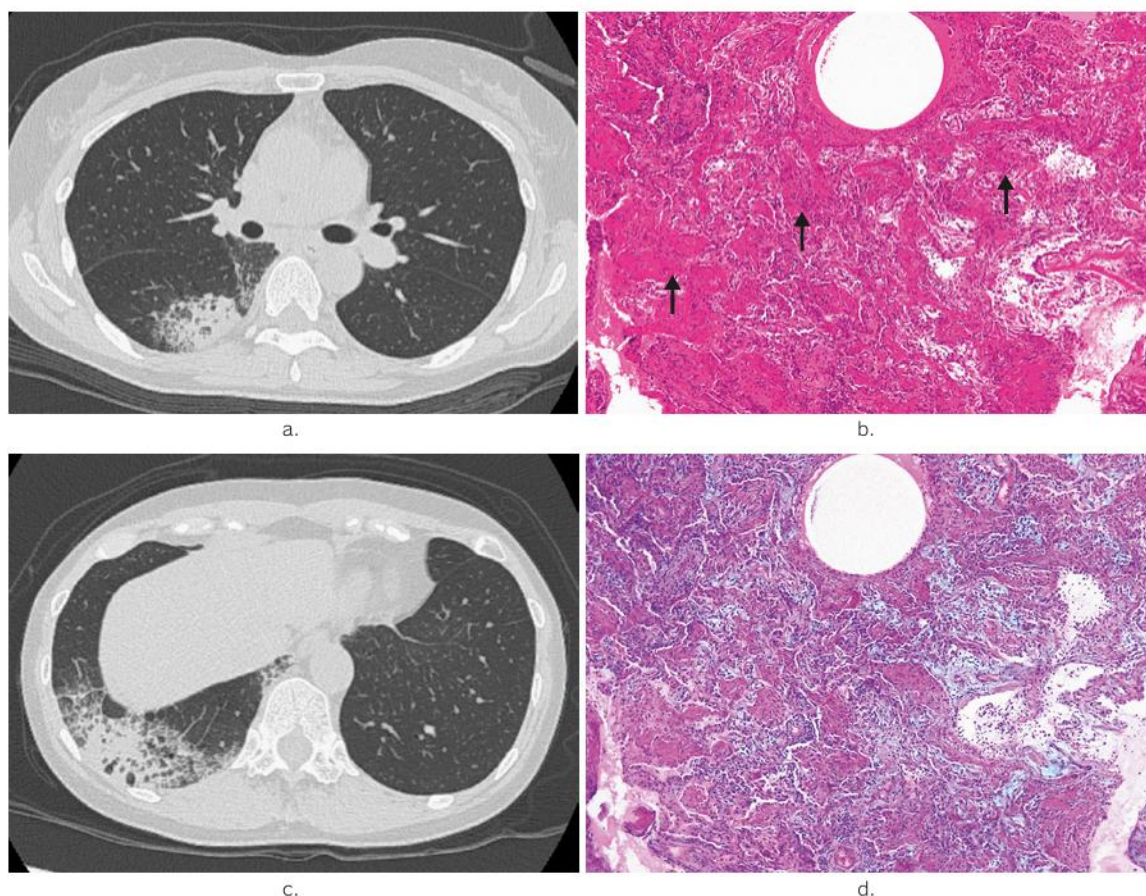


図1 AFOP症例のHRCTと病理組織像(53歳, 女性)

a, c: 胸部CT画像上, 右下葉主体に浸潤陰影を認める。

b: 肺胞腔内にフィブリンの析出が認められる。硝子膜形成は認められない。矢印のように多数のfibrin ballを認める(HE染色)。

d: 肺胞腔内へのフィブリンの析出と器質化を認める(PAS and Alcian blue染色)。

2

bronchiolocentric patterns of interstitial pneumonia (BPIP)

病因・病態・疫学

2013年に改訂された特発性間質性肺炎の国際分類で, 前述のAFOPとともに「まれな組織学的パターン」という分類の中に位置している。

この項には, 以下のような4報の文献が引用されており, airway-centered interstitial fibrosis⁵⁾, peribronchiolar metaplasia⁶⁾, idiopathic bronchiolocentric interstitial pneumonia⁷⁾, bronchiolitis interstitial pneumonitis⁸⁾, 細気管支周囲を主座とする線維化病変をきたすことが示されている⁵⁻⁸⁾。

中高年の女性に多い傾向を認め, 何らかの吸入歴や職業歴があることが多く, 膠原病や喘息などが背景に認められる例もあるが, 喫煙とは強い関連性は認めない。ただし, 原因がはっきりしない例も認められ, 特

発性も存在する^{9, 10)}。

症候・身体所見

いずれにおいても, 息切れ, 呼吸苦, 咳嗽が主な症状である。

診断・検査

多くのケースで, 肺機能検査上拘束性障害を認める。放射線画像所見における共通した特徴はまだはっきりとしていない。

診断には, 肺生検が必要であり, 病理組織の主体は細気管支を中心とする線維化や慢性炎症細胞浸潤である。組織学的には過敏性肺炎と類似している¹⁰⁾。しかし間質性肺炎として存在するのか, 過敏性肺炎などの何らかの経気道吸入要因によって引き起こされる病変の一部を観察しているのかは現時点では不明である⁵⁻¹⁰⁾。